

# MyLoo

*für Patient-Advocates und Gut-Health-Creator - und was die Forschung über das Pitching sagt*

*"Foto rein, KI klassifiziert, Klinik-PDF raus. Privacy-first. Verdien am Wert den du eh erschaffst."*

Du hast geantwortet, danke. Das hier ist der Lang-Begleiter zur Mail. Geht durch was die Forschung zu UGC (Gesicht in die Kamera) vs Faceless sagt und zeigt welcher Pfad zu welchem Creator-Typ passt.

---

Inhalt: 1. App + Business · 2. UGC vs Faceless · 3. Creator-Typen-Tabelle · 4. UGC-Strategie · 5. Faceless-Strategie · 6. Audience-Fit · 7. Cadence · 8. Mathematik · 9. Tracking-Kurzfassung · 10. Onboarding · 11. Dashboard · 12. Brand-Assets · 13. FAQ · 14. Noch eine Sache

## 1. App + Business in 60 Sekunden

MyLoo ist ein Verdauungs- / Stuhl-Tracker für iOS (Android pausiert - Google Health Policy 2026). Foto der Probe, Claude Vision KI klassifiziert auf Bristol-Stuhl-Skala 1-7. Privacy-first: Fotos NICHT gespeichert, nur strukturiertes Ergebnis in Timeline. Symptom-Tags, 30-Tage-PDF für GI-Termin.

### Warum es verkauft

Word-Doc-Tracking ist die Realität für 80% der IBS-Patienten. MyLoo löst genau das: beim GI-Termin zeigst du ein PDF mit echten Daten statt 4 Wochen retrospektiv zu reden.

### Free vs Premium

- Free: manuelle Bristol-Eingabe + Symptom-Tags, Timeline, manueller PDF-Export.
- Premium (4,99 USD/m oder 29,99 USD/y): KI-Foto-Klassifikation, Email-Inbound-Parsing, erweiterter Export.
- Free Lifetime Premium für onboarded Affiliates.

## 2. UGC vs Faceless - was die Forschung sagt

**Face-on-camera-Content (UGC) konvertiert im Schnitt höher als Faceless-Content. Faceless funktioniert trotzdem - nur anders.**

Zwei Befunde aus peer-reviewter Influencer-Marketing-Forschung sind wichtig. Erstens: Sokolova und Kefi (2020) zeigten, dass parasoziale Interaktion - das Gefühl, ein Creator sei ein Freund den du zufällig durchs Handy kennst - ein starker Treiber von Purchase Intent auf Instagram und YouTube ist. Parasoziales Vertrauen baut sich am schnellsten auf wenn Audiences ein Gesicht sehen, eine Stimme hören und einer Person beim Entscheiden zuschauen. Zweitens: Lou und Yuan (2019) fanden, dass wahrgenommene Creator-Glaubwürdigkeit (Vertrauenswürdigkeit, Expertise, Attraktivität) das Konsumenten-Vertrauen in Branded Content direkt erhöht; Creator-Sichtbarkeit ist eines der stärksten Glaubwürdigkeits-Signale. Branchen-Daten aus den jährlichen Influencer-Marketing-Hub-Benchmarks zeigen konsistent dass Face-on-Camera-Reels und -TikToks höheres Engagement haben als reine Screen-Recordings, obwohl die Lücke je nach Nische stark variiert.

### Die Einschränkung

Faceless hat echte Stärken. Wenn die Demonstration selbsterklärend ist - ein Tool das die Sache tut, ein zufriedenstellender B-Roll, ein Screen-Recording das eine 20-Minuten-Aufgabe auf 30 Sekunden komprimiert - ersetzt das Produkt die Persönlichkeit. Faceless skaliert auch: niedrigere Produktionskosten pro Post, keine On-Camera-Nervosität, einfacher auszulagern. Der Preis ist parasoziales Vertrauen, was niedrigere Conversion pro View aber oft höhere Reichweite bedeutet.

### Wann welcher Pfad funktioniert

UGC passt wenn Face-on-Camera dein Glaubwürdigkeits-Asset ist (du, dein Handwerk, deine tägliche Realität), wenn Vertrauen mehr zählt als Reichweite und wenn du natürlich sagen würdest "Ich nutze das persönlich". Faceless passt wenn die Demonstration sich selbst trägt (Produkt auf Screen tut die Arbeit), wenn du Output skalieren willst, wenn On-Camera keine Option ist oder wenn du unter Brand-Persona statt persönlich postest.

### Quellen

- Sokolova, K., & Kefi, H. (2020). Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 53, 101742.
- Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. *Journal of Interactive Advertising*, 19(1), 58-73.
- Influencer Marketing Hub. (2024). *The State of Influencer Marketing Benchmark Report 2024*.
- HypeAuditor. (2024). *State of Influencer Marketing Report*.

### 3. Creator-Typen - welcher Pfad passt zu dir

Für MyLoo speziell konvertieren Creator mit echter Erfahrung deutlich höher als Ästhetik-Accounts - Health-Audiences durchschauen Performance.

| Creator-Typ                                          | Primärer Pfad        | Beste Hook-Winkel                                                                                                          | Realistische Conversion                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>IBS / IBD<br/>Day-in-the-Life</b>                 | UGC stark            | Word-Doc-Moment; "wie ich meinen GI-Termin vorbereite"; 30-Tage-PDF-Reveal; "endlich ein Tool dem ich vertraue"            | 3-5%, sehr hohes Vertrauen + Share-Rate |
| <b>Low-FODMAP /<br/>Food-Intoleranz</b>              | UGC + Faceless Mix   | Food-Symptom-Korrelations-Timeline; "was ich ass vs wie ich mich fühlte"; Trigger-Discovery-Story                          | 2-4% in Eliminations-Diät-Nischen       |
| <b>Patient-Advocate /<br/>IBS-IBD-Educator</b>       | UGC                  | Educational mit persönlichen Daten; "warum die Bristol-Skala zählt"; "was du zum GI mitnimmst"                             | 2-4%, sehr hohe Autorität               |
| <b>Healthcare-Professional in privater Kapazität</b> | UGC (mit Disclosure) | "Was ich mir wünschte meine Patienten würden tracken"; Clinical-Tool-Walkthrough; "das PDF das ich beim Termin sehen will" | 2-4% aber Berufs-Regeln respektieren    |
| <b>Anonymer Gut-Health-TikTok</b>                    | Faceless             | Stille Bristol-Skala-Erklärung; Symptom-Tracking-Voiceless-Tutorial; Privacy-first-Foto-Handling-Demo                      | 1-2% pro View, hohe Posting-Frequenz    |
| <b>Post-OP /<br/>Chronisch-Krank</b>                 | UGC primär           | Recovery-Timeline; "was mich beim Termin gehört fühlen ließ"; strukturiertes Tracking                                      | 2-3% in Chronisch-Krank-Communities     |

### 4. UGC-Strategie (du vor der Kamera)

#### Für wen das passt

Du mit der Kondition. IBS-Patient der Day-in-the-Life teilt. Post-OP-Person die Recovery trackt. Patient-Advocate mit Glaubwürdigkeit. Health-Condition-Content durchschaut Performance - deine echte Erfahrung ist das ganze Glaubwürdigkeits-Modell.

#### Hook-Beispiele die ziehen

- "Das hat mein Word-Doc ersetzt" - Talking Head mit echtem 4-Wochen-Word-Doc, dann MyLoo-Timeline.
- "Wie ich meinen GI-Termin jetzt vorbereite" - ruhig 60s, endend mit PDF-Export.
- "Jahr eins mit IBS - was ich vom ersten Tag an tracken hätte sollen" - Retrospektive.
- "Mein GI-Arzt hat dieses Mal tatsächlich mit den Daten gearbeitet" - Post-Termin-Debrief.
- "KI klassifizierte was ich mich nicht anzuschauen brachte" - Privacy-Angle.
- "Was sich in 30 Tagen Tracking veränderte" - Pattern-Discovery.
- "Warum die Bristol-Skala zählt und warum keiner es dir sagte" - Educational.
- "Meine Low-FODMAP-Eliminations-Woche - was die Timeline zeigte" - Food-Korrelation.

#### Format-Templates

- Talking Head 60s.
- Day-in-the-Life 90s.
- Educational-Vlog 75s.
- Emotionaler Payoff: Post-Termin-Debrief.
- Retrospektive: "Jahr eins mit IBS".
- Vergleich: Word-Doc vs MyLoo.

#### Do / Don't

- Do: nur posten wenn du die Kondition hast oder im Feld arbeitest.
- Do: Kondition oder Kontext spezifisch nennen.
- Do: Privacy ehrlich besprechen.
- Don't: Medical Advice geben.
- Don't: das Marketing medikalisieren.
- Don't: die KI oversellen.

## 5. Faceless-Strategie (Screen-Rec, Voiceover, B-Roll)

### Für wen das passt

Anonymer Patient-Educator. Healthcare-Professional in privater Kapazität. Voiceover-only Chronisch-Krank-Account. Viele Gut-Health-TikTok-Creator sind absichtlich anonym weil Privacy Teil ihres Werts ist.

### Hook-Beispiele die ziehen

- Stille Bristol-Skala-Infografik-Carousel.
- 30s Screen-Rec der KI-Klassifikation mit Voiceover.
- "Privacy-first Foto-Handling - was 'nicht gespeichert' wirklich bedeutet" - Erklärer-Carousel.
- "Was du zu deinem ersten GI-Termin mitnimmst" - Tutorial-Carousel.
- "5 Apps die wirklich bei IBS helfen" - Listicle, MyLoo auf #1-2.
- Symptom-Tracking-Time-Lapse - anonyme Hand.
- "Die Bristol-Skala - drei Dinge die die meisten Patienten nicht kennen" - stille Reel.
- Vergleich: Word-Doc-vs-MyLoo Split-Screen.

### Format-Templates

- Educational-Carousel: 6 Slides, ruhig-klinisch.
- Screen-Rec-Demo 20-30s.
- Voiceover-Narrative 45s.
- Listicle.
- Tutorial: step-by-step Setup.
- Stiller Vergleich.

### Do / Don't

- Do: klinisch-ruhigen Ton - MyLoos Audience-Fit sind Patienten die Wellness-Ästhetik hassen.
- Do: jeden Schritt captionen.
- Do: glaubwürdige Quellen zitieren (NHS, Mayo Clinic, Rom IV) beim Lehren.
- Do: Link in Caption + Bio.
- Don't: bunte Wellness-Ästhetik-Farben.
- Don't: tun als wärst du Patient wenn du es nicht bist.

## 6. Audience-Fit

### Funktioniert gut für

- IBS / IBD Day-in-the-Life Creator.
- Low-FODMAP-Food-Channels.
- Patient-Advocate-IBS/IBD-Pages.
- Post-OP / Chronisch-Krank-Journale.
- Anonyme Gut-Health-TikTok (Privacy als Brand).
- Healthcare-Professionals in privater Kapazität.

### Funktioniert schlecht für

- Wellness-Influencer-Ästhetik.
- Diagnostischer / 'KI sagt dir was du hast'-Angle.
- Generelle Lifestyle-Accounts ohne echte Gut-Health-Verbindung.

## 7. Posting-Cadence + beste Zeiten

Gut-Health: Sonntag-Abend + Mittwoch-Abend. IBS Day-in-the-Life: Di-Do-Morgen. Patient-Advocate: später Abend 21-23h. 1 Reel pro Woche. Stories mit Link nach GI-Terminen treiben Conversion.

## 8. Conversion-Mathematik

50% Rev-Share, 24 Monate. Premium 4,99 USD/m oder 29,99 USD/y. IBS Day-in-the-Life Mikro (40k Follower): 20.000 Views x 2,5% CTR = 500 Clicks, 40% Install = 200 Installs, 6% Premium = 12 Subs, ~180 USD pro Reel. Patient-Advocate Mid-Tier (100k): 50.000 Views x 2% CTR = 1.000 Clicks, 35% Install = 350 Installs, 5% Premium = 17 Subs, ~255 USD. Anonymer Gut-Health Macro (300k TT): 150.000 Views x 1% CTR = 1.500 Clicks, 30% Install = 450 Installs, 4% Premium = 18 Subs, ~270 USD. Chronisch-Krank-User halten Subs länger als Durchschnitt, also 24-Monate-Attribution zahlt häufiger voll aus.

## 9. Tracking-Kurzfassung (volles Walkthrough im Extended Brief)

Dein Link [myloo.org/i/\[handle\]](https://myloo.org/i/[handle]) funktioniert auf jeder Plattform. Android nutzt Google Install-Referrer (deterministisch). iOS warm nutzt Universal Link (deterministisch). iOS cold (~99% des Creator-Traffic) nutzt unseren DIY signed-Token Clipboard-Deferred-Deeplink, live-verifiziert, kein Branch.io. RevenueCat feuert beim Premium-Kauf und creditiert 50% des Netto-Umsatzes auf deinen Handle für 24 Monate ab dem ersten bezahlten Monat jedes Users. 30 Tage Refund-Holdback bevor Auszahlung claimable wird. Volles Walkthrough im Extended-Brief-PDF.

## 10. Onboarding (5 Minuten)

- Klick den persönlichen Link aus Mail 2 (7 Tage gültig).
- Du landest auf [myloo.org/affiliate/\[dein-token\]](https://myloo.org/affiliate/[dein-token]).
- Du füllst aus: Handle, Wise-Payout-Details, Land (Steuer-Dokumente), Rechnungsadresse.
- Du bekommst deinen persönlichen Tracking-Link per Mail + Dashboard-Zugang.
- Free Lifetime Premium Activation-Code per Mail. Kein Posting-Zwang, kein Ablauf.

## 11. Dashboard

- Live auf [getklar.org/dashboard](https://getklar.org/dashboard) (Magic-Link-Login).
- Pro Tag / Woche / Monat: Klicks, Installs (Android / iOS warm / iOS cold getrennt), aktive Premium-Subs aus deinem Bucket.
- Claimable EUR + Paid EUR + nächstes Payout-Datum.
- Refund-Holdback-Pipeline + per-App Earnings-Funnel.

## 12. Brand-Assets

Logo, App-Screenshots, Bristol-Skala-Educational-Slides (medizinisch reviewed), klinisch-ruhige visuelle Identität und fertige Captions: [getklar.org/i/myloo/brand-assets](https://getklar.org/i/myloo/brand-assets).

## 13. FAQ

### **Ich bin Healthcare-Professional, kann ich über MyLoo posten?**

Ja, in privater Kapazität mit Disclosure. Framen als 'Tool das Patienten nutzen können', nicht 'Tool das diagnostiziert'. Lokale Berufs-Regeln befolgen.

### **Was ist mit Android?**

Gebaut und getestet aber pausiert beim Google-Health-Policy-Schritt (Corporate-Account + D-U-N-S erforderlich). Dein Link funktioniert für Android - Waitlist-Page. Attribution gilt rückwirkend wenn Android relaunched.

### **Kann ich echte Fotos zeigen?**

Nein. Privacy-first bedeutet Fotos werden nie gespeichert - das ist der Trust-Unlock. Nutze die strukturierte Ergebnis-Ansicht (Timeline, Bristol, Tags).

### **Kennzeichnung?**

Ja, Rev-Share = bezahlte Empfehlung. Plus: Healthcare-Professionals folgen lokalen Berufs-Regeln.

### **Flat-Fee?**

Mid-Tier \$150-500, Macros \$500+. Rev-Share bleibt obendrauf.

### **Was wenn ich Nischen-Glaubwürdigkeit verliere?**

Nicht posten wenn MyLoo nicht zu deiner echten Erfahrung oder beruflichem Kontext passt. Wir verzichten lieber auf den Post als deine Glaubwürdigkeit zu schädigen.

## 14. Noch eine Sache

Ehrlich: MyLoo passt zu Creators mit echter Gut-Health-Erfahrung oder beruflichem Kontext. Wenn du kein IBS hast, nicht im Healthcare arbeitest, und deine Audience nicht in einer Health-Nische ist, passt nicht und wir hätten lieber dass du nicht postest. Patient-Audiences durchschauen Performance. Antworte auf Mail 2 wenn du reden willst - ja, nein, oder 'vielleicht, lass mal schauen'.

*Bei Posts mit Affiliate-Link: #ad / #Werbung / Paid Partnership (FTC, UWG §5a).*